

Jejum Glicêmico 2D

Guia Simples de Medicamentos para Diabetes Tipo 2

Jejum Glicêmico 2D

Introdução

Esse guia foi feito para te ajudar a entender, de forma clara e direta, como agem os principais medicamentos para o controle do diabetes tipo 2, incluindo as insulinas. Assim, você pode conversar com seu médico com mais segurança e tomar decisões mais conscientes.



Metformina (Biguanida)



Como age:

Ajuda seu fígado a produzir menos glicose e melhora a sensibilidade do seu corpo à insulina.



Risco de hipoglicemia:

Não.



Nomes comerciais:

Glifage, Glifage XR, Dimefor, Glucoformin, Glucomet, Metfor, MetD.

Sulfonilureias



Como agem:

Fazem seu pâncreas liberar mais insulina, mesmo que você não esteja comendo.



Risco de hipoglicemia:

Sim



Nomes comerciais:

- Glibenclamida: Daonil, Glibenclamida Medley, Glibene.
- Gliclazida: Diamicron, Glicazide CR, Diamicron MR.
- Glimepirida: Amaryl, Glimepax, Glimepirida Medley.

Inibidores da DPP-4



Como agem:

Aumentam hormônios naturais que ajudam o corpo a liberar insulina só depois das refeições.



Risco de hipoglicemia:

Não, se usados sem sulfonilureia.



Princípios ativos e nomes comerciais:

- Sitagliptina: Januvia, Janumet (com Metformina).
- Vildagliptina: Galvus, Galvus Met.
- Saxagliptina: Onglyza, Kombiglyze XR (com Metformina).
- Linagliptina: Trajenta, Jentadueto (com Metformina).
- Alogliptina: Nesina.



Análogos do GLP-1 (injeção)



Como agem:

Reduzem o apetite, retardam o esvaziamento do estômago e ajudam a liberar insulina depois das refeições.



Risco de hipoglicemia:

Não, se usados sem sulfonilureia ou insulina.



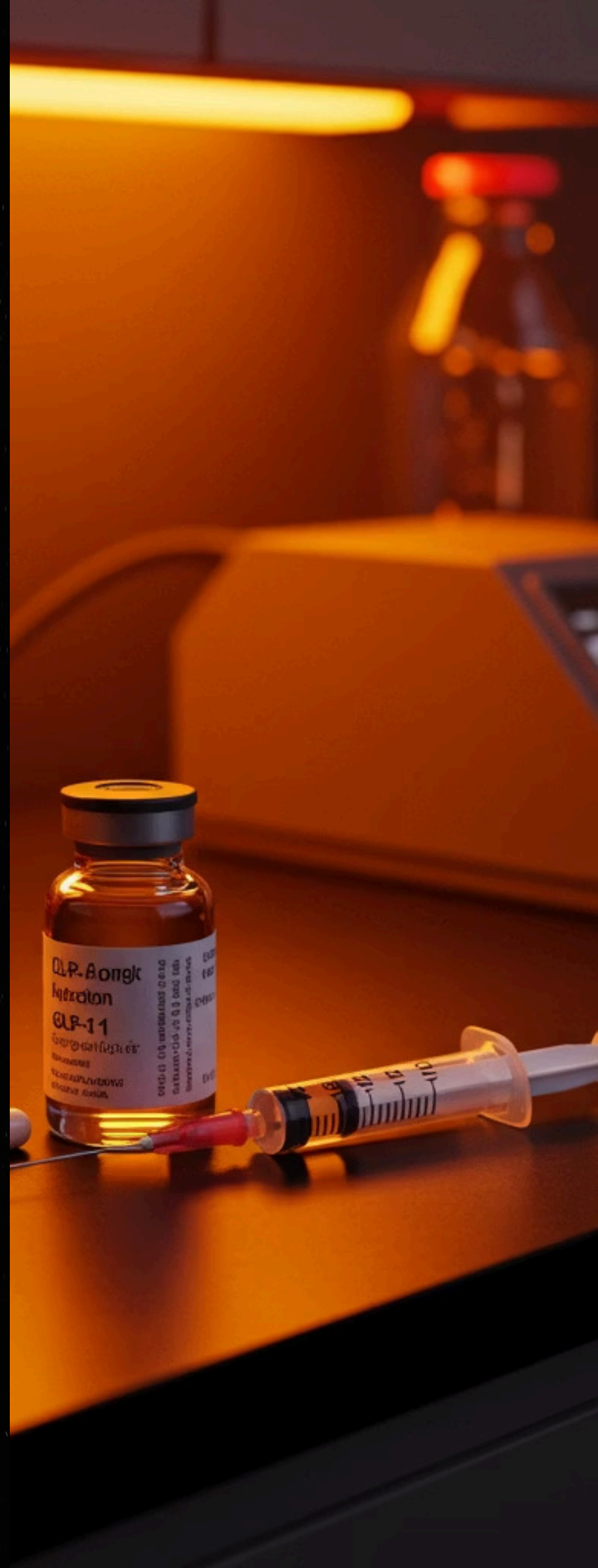
Princípios ativos e nomes comerciais:

Liraglutida: Victoza, Saxenda (usado para obesidade).

Dulaglutida: Trulicity.

Semaglutida: Ozempic, Wegovy (usado para obesidade), Rybelsus (oral).

Tizerpatida: Mounjaro



Inibidores do SGLT2 ("gliflozinas")



Como agem:

Fazem com que o excesso de glicose saia pela urina.



Risco de hipoglicemia:

Não, se usados sozinhos.



Princípios ativos e nomes comerciais:

- Dapagliflozina: Forxiga, Xigduo (com Metformina).
- Empagliflozina: Jardiance, Synjardy.
- Canagliflozina: Invokana.
- Ertugliflozina: Steglatro, Segluromet.



Atenção: Podem aumentar o risco de infecções urinárias e cetoacidose em dietas com pouco carboidrato.



Glitazonas (Tiazolidinedionas)



Como agem:

Aumentam a sensibilidade do seu corpo à insulina.



Risco de hipoglicemia:

Não.



Exemplo:

Pioglitazona (Actos).



Atenção: Pode causar inchaço e ganho de peso.

Inibidores da Alfa-glicosidase



Como agem:

Retardam a absorção do açúcar que você come.



Risco de hipoglicemia:

Não, mas pode causar desconforto abdominal.



Exemplo:

Glucobay (acarbose).



Efeito colateral:

Gases e inchaço.



Insulinas (humanas e análogas)



Basais (ação longa):

- NPH: Insulatard, Humulin N.
- Glargina: Lantus, Basaglar, Toujeo.
- Detemir: Levemir.
- Degludeca: Tresiba.

Rápidas (ação curta):

- Regular: Novolin R, Humulin R.
- Lispro: Humalog.
- Aspart: Novorapid.
- Glulisina: Apidra.

Misturas:

- Insulina NPH + Regular: Novolin 70/30, Humulin 70/30.
- Lispro + Protamina: Humalog Mix 25, Mix 50.



Como agem:

Substituem ou complementam a insulina natural do seu corpo. Existem tipos com ação rápida, intermediária e lenta.



Risco de hipoglicemia:

Sim.



Obs: Deve-se ajustar dose com alimentação e glicemia.

Dica Importante

Nenhum medicamento substitui uma boa alimentação. Mas entender como cada um age te ajuda a colaborar com o tratamento.

-  Se você sentir hipoglicemia (fraqueza, tremedeira, suor frio), não ignore. Meça sua glicemia e, se estiver baixa, corrija com 1 colher de açúcar em $\frac{1}{2}$ copo de água.